



ADOMBOU 2

DEFINITIONS ET TERMINOLOGIES EN GYNECO-OBSTETRIQUE

Les terminologies sont un ensemble de vocabulaire, de termes propres à un domaine, à une technique ou à une science spécifique.

En gynéco-obstétrique, il est important de se familiariser avec certains termes pour mieux appréhender cette science.

Les terminologies sont un ensemble de vocabulaire, de termes propres à un domaine, à une technique ou à une science spécifique.

En gynéco-obstétrique, il est important de se familiariser avec certains termes pour mieux appréhender cette science.

DEFINITIONS

Gynécologie : science qui se consacre à l'appareil génital de la femme ou encore discipline médico-chirurgicale qui traite de la physiologie, de la pathologie, et de la physiopathologie de l'appareil génital féminin.

Gynécologue : personne ayant fait des études universitaires de médecine et qui s'est par la suite spécialisée dans le domaine de la gynécologie. On pourra aussi l'appeler gynécologue.

DEFINITIONS

Obstétrique : discipline médico-chirurgicale qui prend en compte la grossesse, l'accouchement et le post-partum (les suites de couches).

Obstétricien(ne) : vocable donné à celui ou à celle qui pratique l'obstétrique.

NB : la gynécologie et l'obstétrique sont deux disciplines liées, d'où le terme de gynéco-obstétrique. la sage-femme est une obstétricienne à responsabilité limitée (elle n'opère pas)

DEFINITIONS

Gestation : grossesse ou état de grossesse.

Gestante : c'est la femme enceinte ou en grossesse.

Geste : nombre de grossesses antérieures et actuelle.

Gestité : nombre total de grossesse.

Nulligeste : personne n'ayant jamais contracté de grossesse.

Primigeste : personne portant une grossesse pour la première fois.

Parturition : l'acte d'accoucher ou l'accouchement.

DEFINITIONS

Parturiente : personne en travail pour accoucher ou personne en train d'accoucher.

Parité : nombre d'accouchement antérieur.

Primipare : personne ayant accouché une seule fois.

Nullipare : personne qui n'a jamais accouché.

Paucipare : personne qui n'a eu que peu d'accouchement. La pauci-parité est le fait de n'avoir accouché qu'un petit nombre de fois (2 et au plus 3 fois).

Multipare : personne ayant accouché plusieurs fois (au delà de 3 fois).

DEFINITIONS

Embryon : produit de conception couvrant les 3 premiers mois de gestation.

Fœtus : au delà de 3 mois, le produit de conception est appelé fœtus jusqu'à terme.

Délivrance : évacuation du placenta et de ses annexes hors des voies maternelles après la sortie ou l'expulsion du fœtus.

Accouchement : expulsion du fœtus et de ses annexes hors de l'utérus.

Césarienne : accouchement par voie haute qui consiste à faire une intervention chirurgicale sur l'utérus gravide pour extraire le fœtus.

DEFINITIONS

Ante-partum : période avant le travail ou l'accouchement.

Post partum : période qui suit l'accouchement. est aussi les suites de couches.

Globe de sécurité : réaction de l'utérus après la délivrance.
C'est le signe de l'hémostase.

Involution utérine : régression progressive de l'utérus après la délivrance jusqu'à sa localisation initiale.

Montée laiteuse : arrivée du lait dans les seins au troisième jour de l'accouchement.

DEFINITIONS

Colostrum : c'est le premier lait de l'accouchée ; il est de couleur jaunâtre et très riche en protéine et en anti corps.

Méconium : premières selles du bébé de couleur vert foncée, son émission est favorisée par la prise de colostrum.

Cycle menstruel : ensemble de modifications hormonales cycliques de l'organisme féminine dont le terme est l'apparition des règles.

Menstrues : règles, écoulement de sang périodique.

Ménorrhées : écoulement des règles.

DEFINITIONS

Nb : menstrues, menstruation, ménorrhée sont synonymes de règles

Aménorrhées : absence de règles.

Ménorragie : augmentation du volume et de la durée des règles (7à14jours).

Ménométrorragie : association des saignements abondants pendant les menstrues et en dehors de celles-ci

Spanioménorrhée : règles ou menstrues très espacées entre les cycles (supérieurs à 45 jours et parfois à 3 mois).

DEFINITIONS

Oligomenorrhée : diminution de la fréquence et du volume des règles.

Hyperménorrhée : règles trop abondante.

Hypoménorrhée : diminution de la quantité des règles.

Métrorragie : perte de sang ou hémorragie d'origine utérine survenant en dehors des règles.

Dysménorrhée : règles douloureuses et difficiles.

Ménopause : cessation des règles consécutive à l'arrêt de l'activité ovarienne chez la femme (arrêt des cycles menstruels).

DEFINITIONS

Annexes : trompes et ovaires.

Salpinx : autre appellation des trompes de Fallope.

Hystérectomie : ablation chirurgicale de l'utérus en partie ou en totalité.

Hystérotomie : ouverture chirurgicale de l'utérus.

Myomectomie : ablation des myomes.

Myomes : tumeurs bénignes constituées de tissus musculaires lisses situés dans la paroi utérine.

Salpingite : inflammation des trompes.

DEFINITIONS

Salpingectomie : ablation chirurgicale des trompes.

Hydrosalpinx : présence d'eau ou de liquide dans les trompes.

Hystéroggraphie : radiographie ou exploration de l'utérus.

Salpingographie : radiographie ou exploration des trompes.

Hystérosalpingographie (HSG) : exploration de la cavité utérine et des trompes par l'introduction de produit opaque.

Ovaire : gonades femelles où sont produits les ovules.

Ovarite : inflammation de l'ovaire.

Ovariectomie : ablation des ovaires.

DEFINITIONS

Mérites : terme générique donné à toute infection de l'utérus.

Dyspareunie : douleur chez la femme lors des rapports sexuels.

Dystocie : anomalie, difficulté lors du travail d'accouchement.

Cervical : en rapport avec le col de l'utérus.

Col utérin : appelé aussi cervix, est la partie basse de l'utérus qui plonge dans le vagin et doté d'un orifice par lequel s'écoulent les menstrues.

Cervicite : inflammation du col.

Curetage : évacuation du contenu utérin avec un instrument (curette).

DEFINITIONS

Curage : évacuation à l'aide des doigts (digital) du contenu d'une cavité normal ou pathologique (débris placentaires)

Dystocie : anomalie durant l'accouchement.

Dystrophie : conséquence d'un trouble de la nutrition d'un organe.

Eutocie : normal, sans complication.

Gynécologie : science qui se consacre à l'appareil génital de la femme ou encore discipline médico-chirurgicale qui traite de la physiologie, de la pathologie, et de la physiopathologie de l'appareil génital féminin

DEFINITIONS

Gynécologue : personne ayant fait des études universitaires de médecine et qui s'est par la suite spécialisée dans le domaine de la gynécologie. On pourra aussi l'appeler gynécologue.

Obstétrique : discipline médico-chirurgicale qui prend en compte la grossesse, l'accouchement et le post-partum (les suites de couches).

Obstétricien(ne) : vocable donné à celui ou à celle qui pratique l'obstétrique.

DEFINITIONS

NB : la gynécologie et l'obstétrique sont deux disciplines liées, d'où le terme de gynéco-obstétrique. la sage-femme est une obstétricienne à responsabilité limitée (elle n'opère pas)

Gestation : grossesse ou état de grossesse.

Gestante : c'est la femme enceinte ou en grossesse.

Geste : nombre de grossesses antérieures et actuelle.

Gestité : nombre total de grossesse.

Nulligeste : personne n'ayant jamais contracté de grossesse.

Primigeste : personne portant une grossesse pour la première fois.

DEFINITIONS

Parturition : l'acte d'accoucher ou l'accouchement.

Parturiente : personne en travail pour accoucher ou personne en train d'accoucher.

Parité : nombre d'accouchement antérieur.

Primipare : personne ayant accouché une seule fois.

Nullipare : personne qui n'a jamais accouché.

Paucipare : personne qui n'a eu que peu d'accouchement. La pauci-parité est le fait de n'avoir accouché qu'un petit nombre de fois (2 et au plus 3 fois).

DEFINITIONS

Multipare : personne ayant accouché plusieurs fois (au delà de 3 fois).

Embryon : produit de conception couvrant les 3 premiers mois de gestation.

Fœtus : au delà de 3 mois, le produit de conception est appelé fœtus jusqu'à terme.

Délivrance : évacuation du placenta et de ses annexes hors des voies maternelles après la sortie ou l'expulsion du fœtus.

Accouchement : expulsion du fœtus et de ses annexes hors de l'utérus.

DEFINITIONS

Césarienne : accouchement par voie haute qui consiste à faire une intervention chirurgicale sur l'utérus gravide pour extraire le fœtus.

Ante-partum : période avant le travail ou l'accouchement.

Post partum : période qui suit l'accouchement. est aussi les suites de couches.

Globe de sécurité : réaction de l'utérus après la délivrance. C'est le signe de l'hémostase.

Involution utérine : régression progressive de l'utérus après la délivrance jusqu'à sa localisation initiale.

DEFINITIONS

Montée laiteuse : arrivée du lait dans les seins au troisième jour de l'accouchement.

Colostrum : c'est le premier lait de l'accouchée ; il est de couleur jaunâtre et très riche en protéine et en anti corps.

Méconium : premières selles du bébé de couleur vert foncée, son émission est favorisée par la prise de colostrum.

Cycle menstruel : ensemble de modifications hormonales cycliques de l'organisme féminine dont le terme est l'apparition des règles.

DEFINITIONS

Menstrues : règles, écoulement de sang périodique.

Ménorrhées : écoulement des règles.

Nb : menstrues, menstruation, ménorrhée sont synonymes de règles

Aménorrhées : absence de règles.

Ménorragie : augmentation du volume et de la durée des règles (7à14jours).

Ménométrorragie : association des saignements abondants pendant les menstrues et en dehors de celles-ci

DEFINITIONS

Spanioménorrhée : règles ou menstrues très espacées entre les cycles (supérieurs à 45 jours et parfois à 3 mois).

Oligomenorrhée : diminution de la fréquence et du volume des règles.

Hyperménorrhée : règles trop abondante.

Hypoménorrhée : diminution de la quantité des règles.

Métrorragie : perte de sang ou hémorragie d'origine utérine survenant en dehors des règles.

Dysménorrhée : règles douloureuses et difficiles.

DEFINITIONS

Ménopause : cessation des règles consécutive à l'arrêt de l'activité ovarienne chez la femme (arrêt des cycles menstruels).

Annexes : trompes et ovaires.

Salpinx : autre appellation des trompes de Fallope.

Hystérectomie : ablation chirurgicale de l'utérus en partie ou en totalité.

Hystérotomie : ouverture chirurgicale de l'utérus.

Myomectomie : ablation des myomes.

Myomes : tumeurs bénignes constituées de tissus musculaires lisses situés dans la paroi utérine.

DEFINITIONS

Salpingite : inflammation des trompes.

Salpingectomie : ablation chirurgicale des trompes.

Hydrosalpinx : présence d'eau ou de liquide dans les trompes.

Hystérographie : radiographie ou exploration de l'utérus.

Salpingographie : radiographie ou exploration des trompes.

Hystérosalpingographie (HSG) : exploration de la cavité utérine et des trompes par l'introduction de produit opaque.

Ovaire : gonades femelles où sont produits les ovules.

Ovarite : inflammation de l'ovaire.

DEFINITIONS

Ovariectomie : ablation des ovaires.

Mérites : terme générique donné à toute infection de l'utérus.

Dyspareunie : douleur chez la femme lors des rapports sexuels.

Dystocie : anomalie, difficulté lors du travail d'accouchement.

Cervical : en rapport avec le col de l'utérus.

Col utérin : appelé aussi cervix, est la partie basse de l'utérus qui plonge dans le vagin et doté d'un orifice par lequel s'écoulent les menstrues.

Cervicite : inflammation du col.

DEFINITIONS

Curetage : évacuation du contenu utérin avec un instrument (curette).

Curage : évacuation à l'aide des doigts (digital) du contenu d'une cavité normal ou pathologique (débris placentaires)

Dystocie : anomalie durant l'accouchement.

Dystrophie : conséquence d'un trouble de la nutrition d'un organe.

Eutocie : normal, sans complication.

Quelques exemples :

Ecto	suffixe	ablation. Exemple salpingectomie.
Ites	suffixe	inflammation. Exemple cervicite.
Ragie	suffixe	saignement. Exemple métrorragie.
Tomie	suffixe	ouverture, incision, section. Exemple :
hystérotomie		
Raphie	suffixe	réfection. Exemple : hystéroraphie
Rrhées	suffixe	écoulement. Exemple : hyperménorrhées.
Dys	préfixe	gène, difficulté. Exemple : dysménorrhée.
Algies	suffixe	douleur. Exemple pelvialgie.

Quelques exemples :

Anté	préfixe	avant.	Exemple : anténatal.
Cèle	suffixe	hernie.	Exemple : hydrocèle.
Cyst	préfixe	vessie.	Exemple : cystite.
Emie	suffixe	sang.	Exemple : anémie
Ose	suffixe	maladie chronique inflammatoire.	
Exemple : arthroses.			

Quelques exemples :

Pré	préfixe	avant. Exemple : pré-éclampsie
Sus	préfixe	au dessus. Exemple : sus hépatique.
Pyo	préfixe	pus. Exemple : pyosalpinx
Post	préfixe	après. Exemple : post-partum.
Per	préfixe	pendant. Exemple : per-coïtal

GENERALITES SUR LES SOINS OBSTETRICaux ET NEONATAUX



OBJECTIF GENERAL

Connaitre les généralités sur les SONU

OBJECTIF SPECIFIQUES

1. Donner la définition de la mortalité maternelle
2. Citer les causes de mortalité maternelle
3. Expliquer les facteurs de mortalité maternelle
4. Citer les fonctions des établissements des SONU
5. Décrire les indicateurs de processus

❖ la mortalité maternelle: (OMS)

- ☐ tout décès survenu au cours de la **grossesse**, l'accouchement ou dans les **42 jours**
- ☐ Quelle qu'en soit **la durée** ou la **localisation**
- ☐ toute cause liée à la grossesse
- ☐ ou **aggravée** par la grossesse

CONTEXTE

- Les estimations de l'**OMS** portent à 536 000 les décès maternels chaque année (2005).
- Plus d'une femme meurt chaque minute de causes liées à la grossesse

Dans l'espace CEDEAO

- Chaque jour
- 225 femmes meurent en donnant la vie
- 1.197 nouveau- nés meurent

- **En Côte d'Ivoire**
- Mortalité maternelle élevée : 617 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes (EIS 2017)
- 16 femmes meurent par jour
- Mortalité néonatale : 41/1.000

DEFINITION DES SONU

- ☐ Soins Obstétricaux et Néonataux d'Urgence
- ☐ Offerts en **urgence** à toute femme et/ou à son enfant,
- ☐ Présentant des complications au cours de la grossesse, du travail et des suites de couches .

CAUSES DE LA MORTALITE MATERNELLE



CAUSES DE LA MORTALITE MATERNELLE

- ☐ Causes obstétricales **directes** (COD) : 3/4 des décès maternel
- ☐ causes obstétricales **indirectes** (COI) : 1/4 des décès maternels

CAUSES OBSTÉTRICALES DIRECTES (COD)

□ Résultent de complications obstétricales (grossesse, travail et suites des couches),

- **Hémorragie** 21%
- **Avortement à risques** 14%
- **Eclampsie** 13%
- **Travail dystocique** 8%
- **Infection** 8%
- **Autre** 11%

CAUSES OBSTÉTRICALES INDIRECTES (COI)

❑ **causes obstétricales indirectes (COI) : 1/4 des décès maternels**

Résultent d'une maladie préexistante ou d'une affection apparue au cours de la grossesse sans qu'elle soit due à des causes obstétricales mais qui a été aggravée par les effets physiologiques de la grossesse.

CAUSES OBSTÉTRICALES INDIRECTES (COI)

□ causes obstétricales indirectes (COI) : 1/4

des décès maternels:

- paludisme,
- anémie et l'hépatite ,
- VIH/SIDA



OÙ meurent les femmes de nos jours ?

- 99% des décès maternels surviennent en Afrique, Asie et Amérique latine.
- La plupart des complications obstétricales ne peuvent être ni prévues ni prévenues
- Mais si les femmes reçoivent un traitement efficace à temps
Presque toutes d'entre elles peuvent être sauvées.

De combien de temps disposons-nous ?

En l'absence de traitement, le décès survient :

- **02 heures** → suite à l'**hémorragie du postpartum**
- **12 heures** → suite à l'**hémorragie anté-partum**
- **02 jours** → suite au **travail dystocique**
- **06 jours** → suite à l'**infection**

Qu'est l'incapacité maternelle ?

- ❑ Maladie à court ou à long terme causée par des complications obstétricales

Type de morbidité

- Infections pelviennes
- Incontinence urinaire
- Infertilités
- Anémies graves
- Fistules obstétricales (*Passage anormal entre le vagin et la vessie ou le rectum, souvent causé par un travail dystocique qui n'est pas traité par césarienne*)

•

FACTEURS FAVORISANT LA MORTALITE MATERNELLE

- ☐ Trois retards
- ☐ Facteurs liés à la procréation
- ☐ Facteurs économiques

FACTEURS LIES AUX TROIS RETARDS

□ 1^{ER} RETARD

- Méconnaissance des signes de danger
- Lenteur dans la prise de décision et
- Faible pouvoir de décision de la femme

FACTEURS DE LA MORTALITE MATERNELLE

❑ 2^{ÈME} RETARD

- Longues distances
- Mauvais état des routes
- Insuffisance de moyens de référence adéquats
- Faible revenu des ménages

FACTEURS DE LA MORTALITE MATERNELLE

❑ 3^{ÈME} RETARD

- **Insuffisance :**
 - en personnel
 - en équipement
 - en médicaments et consommables
- **Faible motivation du personnel**

FACTEURS LIÉS À LA PROCRÉATION

❑ 4 « **TROP** » ; grossesses:

- **trop** précoces → < 18 ans
- **trop** tardives, → > 35 ans
- **trop** nombreuses, → parité > 4
- **trop** rapprochées) → espace inter
génésiq ue < 2 ans

❑ **Avortements** à **risque** pour grossesses non désirées.

FACTEURS ÉCONOMIQUES

- Pauvreté
- Vulnérabilité économique
- Absence de couverture maladie
- Absence de planification économique

- Forte Fécondité : 4,6 enfants par femme (EIS 2005)
- Maternité précoce: à 19 ans, 53% des femmes ont déjà donné naissances à un enfant
- Intervalle inter génésique court (moins de 2 ans)
- Faible recours à la contraception moderne: prévalence contraceptive de 13% (MICS 2006)
- Accouchement assisté par le personnel (taux à rechercher)

- Pour éviter le décès et l'incapacité de la mère et du nouveau né, nous devons assurer l'accès de ces populations aux soins obstétricaux et néonataux d'urgence (SONU).

FONCTIONS DES ÉTABLISSEMENTS DES SONU DE BASE (SONUB)

1. Antibiotiques (voie intraveineuse ou injection IM)
2. Médicaments ocytotiques (par voie intraveineuse ou injection IM)
3. Anticonvulsivants (par voie intraveineuse ou injection IM)

FONCTIONS DES ÉTABLISSEMENTS DES SONU DE BASE (SONUB)

4. Délivrance artificielle
5. Extraction des produits retenus de la conception
6. Accouchement par voie basse avec assistance
7. Les soins essentiels au nouveau né

FONCTIONS DES ETABLISSEMENTS SONU COMPLETS(SONUC)

1. Antibiotiques (par voie intraveineuse ou injection)
2. Médicaments ocytotiques (idem)
3. Anticonvulsivants (idem)
4. Délivrance artificielle
5. Transfusion de sang

FONCTIONS DES ETABLISSEMENTS SONU COMPLETS

6. Extraction des produits retenus de la conception (Restes d'avmt)
7. Accouchement par voie basse avec assistance(ventouse)
8. La réanimation au nouveau -né
9. Interventions obstétricales majeures (césarienne et hystérectomies etc)

INDICATEURS DE PROCESSUS DES SONU

- En général, les indicateurs de processus vous montrent les changements dans les conditions qui mènent au résultat (décès ou incapacité)
- **Les 6 Indicateurs du processus nous montrent les changements dans : l'accès, l'utilisation, et la qualité des services SONU.**

Indicateurs de processus des SONU

- **1^{er} Indicateur**
- Pour 500 000 personnes, il faudrait au moins :
- 1 établissement de SONU Complets
- 4 Établissements de SONU de Base

2^{ème} Indicateur

- **Distribution géographique des établissements de SONU**
- Les établissements de SONU devraient être bien répartis pour desservir 500 000 personnes
- Minimum : 1 établissement de SONU Complets et 4 établissements de SONU de Base

- **3^{ème} Indicateur**
- **Proportion de toutes les naissances dans les établissements de SONU**
- **Au moins 15% de toutes les naissances dans la communauté devraient se faire dans les établissements de SONU**

- **4^{ème} Indicateur**
- **Besoin satisfait pour les services de SONU**
- Au moins 100% des femmes avec des complications obstétricales devraient être traitées dans les établissements de SONU

- **5^{ème} Indicateur**
- Césariennes en tant que pourcentage de toutes les naissances
- Minimum : 5%
- Maximum : 15%

6^{ème} Indicateur

- **Taux de létalité**
- Proportion de toutes les femmes avec complications obstétricale admises dans un établissement qui meurent :
Niveau acceptable maximum : 1%

CONCLUSION

La plupart des complications obstétricales ne peuvent être ni prévues ni prévenues mais si les femmes reçoivent un traitement efficace à temps, Presque toutes d'entre elles peuvent être sauvées.

- Tout pays peut éviter la mortalité et l'incapacité maternelles s'il rend les SONU disponibles et accessibles à temps.



INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTE - INFAS

Blvd de Marseille, 18 BP 720 Abidjan 18, Tel.: (225) 21005660 / 21001906 – Email: info@infas.ci – site web: www.infas.ci

ROLE DE L'INFIRMIER DANS LES CONSULTATIONS PRENATALES RECENTREES



INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTE - INFAS

Blvd de Marseille, 18 BP 720 Abidjan 18, Tel.: (225) 21005660 / 21001906 – Email: info@infas.ci – site web: www.infas.ci

OBJECTIF GENERAL

- Connaitre les éléments de réalisation d'une consultation prénatale recentrée.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Définir le concept de soins prénatals recentrés
2. Décrire les quatre principales composantes des soins prénatals recentrés
3. Décrire la fréquence et la programmation adéquate des consultations prénatales
4. Enoncer les éléments essentiels d'un plan de préparation à l'accouchement et aux complications

DEFINITION

Approche des soins prénatals qui insiste sur :

1. Des actions basées sur l'évidence et orientée vers un objectif
2. Des soins individualisés axés sur chaque femme
3. La qualité des visites par opposition à leur nombre en faisant une analyse pertinente des résultats de la séance de CPN
4. Des soins donnés par des partenaires compétents. Il s'agit d'actions ciblées et non routinières.

PRINCIPES (05)

- 1. Evaluation focalisée à chaque visite prénatale (dépister et traiter les maladies préexistantes et les complications)**

2. Soins individualisés

- Prendre en compte :
- la prévention des complications et des maladies
- La préparation à l'accouchement et aux complications
- la promotion de la santé

PRINCIPES (05)

- **3. Bon counseling et soutien**
- Ils permettent à la femme de:
- prendre une part active aux soins
- prendre des décisions adéquates
- mener une vie saine pour préserver sa santé
- suivre les conseils prodigués.
- faire confiance au prestataire.

PRINCIPES (05)

4. Soins centrés sur la femme

- Ils mettent l'accent sur :
- la priorité donnée à la santé / suivie de la mère et du nouveau-né
- le respect des droits, de la culture, des croyances et du genre
- les messages et conseils de santé appropriés, faisables en fonction du contexte
- l'accessibilité des services par les femmes
- l'utilisation d'une bonne communication interpersonnelle

PRINCIPES (05)

5. Soins assurés par un prestataire qualifié et compétent

- Médecin
- Sage-femme (SF)
- Infirmier (IDE).

COMPOSANTES DE LA CPN RECENTREE

- 1. Dépistage et PEC des maladies préexistants et des complications
- 2. Prévention des complications et des maladies
- 3. Préparation à l'accouchement et aux complications éventuelles
- 4. Promotion de la santé

Dépistage et PEC des maladies préexistantes et des complications

- Paludisme (fièvre, anémie, goutte épaisse / Frottis ou test de diagnostic rapide)
- Infections urinaires (dysurie, pollakiurie, fièvre, douleurs pelviennes, lombaires, ECBU)
- Pré éclampsie (HTA, œdèmes des membres inférieurs, reflexes tendineux, protéinurie)

Dépistage et PEC des maladies préexistantes et des complications

- Anémie (pâleur des conjonctives, des paumes, de la langue ; taux d'hémoglobine et d'hématocrite)
- Maladie des seins (douleurs mammaires, nodules mammaires, écoulement mammaire anormal)

Dépistage et PEC des maladies préexistantes et des complications

- Retard de croissance, mort fœtale (MAF, HU, BDCAF)
- Infections sexuellement transmissibles (leucorrhées, condylomes vulvaires, examen pelvien et au spéculum)
- Cancer du col (Inspection visuelle, examen pelvien et au spéculum)

❖ **Nombre de CPN**
minimum (04)

Déroulement de la CPN

❖ **la 1^{ère} CPN: Avant la fin du 3^{ème} mois**

- Diagnostiquer la grossesse
- Dépister les facteurs de risque
- Etablir la déclaration de grossesse
- Faire le VAT

Déroulement de la CPN

❖ la 1^{ère} CPN: Avant la fin du 3^{ème} mois

- Prévenir le paludisme (moustiquaire imprégnée)
- Faire la supplémentation en acide folique
- Faire le Conseil Dépistage Volontaire (CDV)
- Prescrire le bilan prénatal.

Déroulement de la CPN

❖ La 2^{ème} CPN : 4^{ème} au..... 6^{ème} mois

- Suivre l'évolution de la grossesse
- Rechercher les facteurs de risque de prématurité
- Traiter les maladies courantes et associées
- Faire la prophylaxie antianémique
- Donner la 1^{ère} dose de la chimio prophylaxie anti palustre (TPI).
- Vacciner si nécessaire.

Déroulement de la CPN

❖ La 3^{ème} CPN: Entre le 7^{ème} et le 8^{ème} mois

- Apprécier l'évolution de la grossesse (recherche des signes de prématurité)
- Sensibiliser à l'environnement de l'accouchement
- Vacciner si nécessaire
- Donner la 2^{ème} dose des TPI

Déroulement de la CPN

❖ La 4^{ème} CPN: 9^{ème} mois

- Faire le pronostic de l'accouchement
- Référer en cas de besoin
- Faire la vaccination si nécessaire

BILAN AU COURS DE LA GROSSESSE

- ❖ **Examen de laboratoire par ordre de priorité**
- Groupe sanguin (ABO + Rhésus)
- Taux d'hémoglobine et hématocrite
- Albumine – sucre dans les urines (à toutes les CPN)
- Electrophorèse de l'hémoglobine

BILAN AU COURS DE LA GROSSESSE

❖ Examen de laboratoire par ordre de priorité

- Sérologie de la toxoplasmose (si négatif surveiller tous les mois)
- Sérologie de la rubéole (au 1^{er} Trimestre)
- Sérologie de la syphilis (VDRL – TPHA)
- Nitrite dans les urines (si positif faire un ECBU)
- Sérologie VIH après consentement éclairé.

❖ Examen d'échographie (03)

- 1^{ère} diagnostic de grossesse au 1^{er} Trimestre
- 2^{ème} morphologie fœtale au 2^{ème} Trimestre
- 3^{ème} pronostic de l'accouchement au 3^{ème} Trimestre
-

PRÉVENTION DES COMPLICATIONS ET DES MALADIES

- Chaque femme enceinte doit bénéficier des mesures préventives suivantes :
- Vaccination antitétanique
- Supplémentation en fer/folate
- Prévention du paludisme
- Prévention des troubles dus à la carence en iode par consommation de sel iodé.

PRÉPARATION À L'ACCOUCHEMENT ET AUX COMPLICATIONS ÉVENTUELLES

- Identification d'un prestataire qualifié pour l'accouchement
- Identification du lieu de l'accouchement
- Identification du moyen de transport pour se rendre à l'hôpital
- Identification des moyens financiers.

PRÉPARATION À L'ACCOUCHEMENT ET AUX COMPLICATIONS ÉVENTUELLES

- Identification du système de prise de décisions en cas d'urgence
- Identification de donneurs de sang
- Identification du soutien familial pendant le séjour à la maternité
- Identification des articles nécessaires le jour de l'accouchement.

Elle peut se faire au centre de santé ou dans la communauté à travers plusieurs thèmes dont la prévention du paludisme, l'alimentation de la femme enceinte et du nouveau-né, l'hygiène générale, la planification familiale etc...



CONSULTATION DU 1^{er} TRIMESTRE DE LA GROSSESSE



INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTE - INFAS

Blvd de Marseille, 18 BP 720 Abidjan 18, Tel.: (225) 21005660 / 21001906 – Email: info@infas.ci – site web: www.infas.ci

OBJECTIF GENERAL

Connaitre les étapes de réalisation de la première consultation prénatale.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- 1- Citer tout le matériel nécessaire pour la réalisation d'une consultation prénatale
- 2- Donner les éléments de l'interrogatoire de la première consultation prénatale

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- 3- Décrire le calcul de l'âge gestationnel en semaines et le terme probable d'une grossesse à partir de la date des dernières règles
- 4- Citer les différentes étapes d'une consultation prénatale
- 5- Décrire la procédure de l'examen gynécologique au cours de la consultation
- 6- Citer tous les éléments du bilan prénatal

❖ **Diagnostic positif de la grossesse**

Clinique (signes cliniques)

Paraclinique (examen de laboratoire)

❖ **Définition de la CPN**

C'est l'ensemble des soins prénatals dont bénéficient les mères.

❖ **But**

Réduction de la mortalité maternelle et néonatale

❖ INTERROGATOIRE

- Antécédents : médicaux, chirurgicaux, gynécologiques et obstétricaux
- Histoire de la grossesse (DDR)
- Calcul de l'AG

Exemple DDR le 05 Mars 2022 et le jour du calcul est le 28 Aout 2022.

- Mars = reste 26jrs(3semaines + 5jrs)

❖ INTERROGATOIRE

• Calcul de l'AG

Exemple DDR le 05 Mars 2022 et le jour du calcul est le 28 Aout 2022.

- Mars = reste 26jrs(3semaines + 5jrs)
- Avril= 30jrs(4semaines+2jrs)
- Mai=31jrs(4semaines +3jrs)
- Juin=30jrs(4semaines +2jrs)

❖ INTERROGATOIRE

- Calcul de l'AG

Juillet= 31jrs(4semaines +3jrs)

28Aout= 28jrs(4semaines)

- Age gestationnel = 25semaines +1jr
- Le terme normal d'une grossesse est de 40 sem
- Calcul de la date probable de l'accouchement
(DDR +7JRS) – 3mois ou (DDR+7JRS) +9 mois

❖ EXAMEN CLINIQUE

➤ Examen général

- Il consiste à prendre la tension artérielle(TA), le poids, la température, le pouls, le périmètre brachial, la taille, de rechercher l'albumine et le sucre dans les urines.

❖ EXAMEN CLINIQUE

- Examen physique : l'inspection, la palpation, l'auscultation
- et l'examen gynécologique

- Observer le facies,
- Inspecter les conjonctives à la recherche d'une anémie et les yeux à la recherche d'un ictère,
- Examiner :
- La bouche (gingivite, langue saburrale, carie dentaire, herpes= boutons de fièvre)

❖ EXAMEN CLINIQUE

➤ Examen physique : l'inspection, la palpation et l'examen gynécologique

- Le cou (goitre, ganglion),
- Les seins à la recherche de nodules ou de sécrétion,
- L'abdomen (vergeture, cicatrice)
- La vulve (varice, écoulement vulvaire, mutilation génitale)
- Membres inférieurs (varices, œdèmes)

❖ EXAMEN CLINIQUE

➤ Examen obstétrical

- Il repose essentiellement sur le toucher vaginal mais avant si possible faire un examen au spéculum.
- Le toucher vaginal combiné au palper recherche la position, la longueur, la consistance ainsi que la perméabilité du col et apprécie aussi la taille de l'utérus (en semaines d'aménorrhée).
- Apprécier toujours ce que ramène le doigtier.

❖ EXAMEN CLINIQUE

➤ Examens complémentaires

Examens de laboratoire

• Sang

- ✓ groupe sanguin ABO- rhésus,
- ✓ taux d'hémoglobine et d'hématocrite
- ✓ glycémie,
- ✓ sérologie de la rubéole,
- ✓ sérologie de la toxoplasmose,

❖ EXAMEN CLINIQUE

➤ Examens complémentaires

Examens de laboratoire

• Sang

- ✓ sérologie de la syphilis (TPHA-VDRL)
- ✓ sérologie virale de l'hépatite A, B et C
- ✓ urée et créatinémie
- ✓ sérologie VIH après consentement éclairé
- ✓ électrophorèse de l'hémoglobine

❖ EXAMEN CLINIQUE

➤ Examens complémentaires

Examens de laboratoire

- Urine

- ✓ albumine

- ✓ sucre

- ✓ nitrite (positif, demander l'ECBU)

❖ EXAMEN CLINIQUE

➤ Examens complémentaires

Examens de laboratoire

- Selles (orienté)

❖ EXAMEN CLINIQUE

➤ Examens complémentaires

Examen radiologique

- ✓ La première échographie du premier trimestre pour confirmer la grossesse.
- **NB : Faire toujours la conclusion de votre examen avant la conduite à tenir.**

❖ CONDUITE A TENIR

➤ Curative

- Elle est orientée (selon les plaintes de la gestante)

➤ Préventive

- Acide folique
- VAT si nécessaire

❖ CONDUITE A TENIR

➤ CCC

- Elles doivent être en rapport avec :
- l'hygiène corporelle, vestimentaire, alimentaire et de l'habitat,
- la prévention du paludisme (MILDA, assainissement de l'environnement)
- la proscription de l'alcool, du tabac et des drogues
- la préparation à l'accouchement.

CONDUITE A TENIR

➤ RDV ou quand revenir

- Orienter la cliente selon le cas qu'elle présente.
- La sage-femme fait la surveillance de la grossesse normale.

CONDUITE A TENIR

NB : Insister sur la déclaration de la grossesse et la délivrance du certificat de grossesse du premier trimestre (15 semaines).

- La législation prévoit quatre (4) consultations prénatales obligatoires.

CONSULTATION PRENATAL DU 2^{ème} ET 3^{ème} TRIMESTRE



INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTE - INFAS

Blvd de Marseille, 18 BP 720 Abidjan 18, Tel.: (225) 21005660 / 21001906 – Email: info@infas.ci – site web: www.infas.ci

OBJECTIF GENERAL

Connaitre les éléments du suivi d'une grossesse normale au 2^{ème} et 3^{ème} trimestre.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Décrire les différentes étapes de la consultation du 2^{ème} et 3^{ème} trimestre
2. Expliquer la conduite à tenir

C.P.N. DU 2^{ème} TRIMESTRE

- Elle vise à suivre l'évolution de la grossesse

C.P.N. DU 2^{ème} TRIMESTRE

1-1- Les différentes étapes

1-1-1- L'interrogatoire

Noter tous les changements signalés par la patiente depuis la 1^{ère} consultation.

L'interrogatoire doit porter sur :
la recherche de douleurs pelviennes, de contractions utérines,
la recherche de saignements, de pertes vaginales prurigineuses ou malodorantes.

C.P.N. DU 2^{ème} TRIMESTRE

Les différentes étapes

❖ L'interrogatoire

- La recherche de signes fonctionnels urinaires (brûlure mictionnelles, douleur à la miction)
- Apprécier l'intensité des vomissements
- L'apparition de mouvements actifs du fœtus :
 - Primipare 4 à 4 mois $\frac{1}{2}$ environ 18 semaines
 - Multipare dès 3 mois $\frac{1}{2}$ environ 14 semaines

❖ L'examen clinique

➤ Examen général (voir 1^{er} trimestre)

N.B. : Après la pesée, il faut évaluer et noter la prise de poids qui doit être de 10 à 12 kg au cours des 9 mois.

➤ Inspection (voir 1^{ère} trimestre).

L'examen clinique

➤ Examen obstétrical

Il commence par les mensurations : la femme couchée en position gynécologique jambes fléchies, vessie et rectum préalablement vides.

Mesurer la hauteur utérine

Entre 4 et 7 mois, HU (cm) = Mois de grossesse x 4

**Au 8e et 9e mois, HU (cm) = [Mois de grossesse x 4] - 2 cm
(par mois)**

3 mois (12 semaines) HU = 9 cm

4 mois (20 semaines) HU = 16 cm

5 mois (24 semaines) HU = 20 cm

6 mois (28 semaines) HU = 24 cm

7 mois (32 semaines) HU = 28 cm

8 mois (36 semaines) HU = 30 cm

9 mois (40 semaines) HU = 32 – 33 cm Repères de l'évolution
de la Hauteur Utérine

Mesure du périmètre ombilical passant par l'ombilic.

➤ **Palpation.**

Jusqu'à 6 mois la présentation n'est pas définie, le fœtus étant trop petit et mobile dans le liquide amniotique on parle donc de ballottement fœtal.

Auscultation

Au stéthoscope obstétrical les BDCF sont audibles à partir de la 24^{ème} semaine. Ils sont perceptibles à l'ombilic. Ils doivent être réguliers, il faut les chronométrer ($120\text{batts/mn} < \text{BDCF} < 160\text{batts/mn}$)

Examen au spéculum

Il apprécie la coloration, la longueur et le degré d'ouverture du col.

TV : Idem 1^{er} trimestre

Il recherche la position, la longueur, la consistance et le degré d'ouverture du col.

N.B : rechercher une éventuelle béance du col afin de dépister un risque de fausse couche.

❖ C A T

Interpréter les résultats du bilan prénatal

Faire la conclusion de votre examen avant d'aborder la conduite à tenir.

Demander à nouveau certains éléments du bilan prénatal

C A T

Demander l'échographie du 2^{ème} trimestre (morphologie, localisation placentaire, vitalité du fœtus, quantité du liquide amniotique, biométrie fœtale, pathologies funiculaires)

Prescription

Donner un anti anémique et un anti palustre (à partir de la 16^{ème} semaine ou si MAF positifs)

✓ **Traitement curatif**

Il est fonction de la pathologie que présente la patiente.

Faire un déparasitage si nécessaire (à parti du 2^{ème} trimestre)

✓ **Traitement prophylactique**

Anti anémique

Anti palustre : 3 doses de (sulfadoxine pyriméthamine) au cours de la grossesse ; dans tous les cas la dernière dose se prend au plus tard à 8 mois de grossesse et avant 32 semaines pour les séropositives.

Vaccination si nécessaire

Développer des thèmes de CCC en rapport avec l'état de la patiente et donner la date du prochain RDV et quand revenir(en cas de fièvre, de métrorragie, de douleurs pelviennes, de perte des eaux et en cas d'absence de MAF).

CPN DU 3^{ème} TRIMESTRE

- ❖ Les différentes étapes
- L'interrogation (Identique au 2^{ème} trimestre)



❖ Examen clinique:

✓ Examen général

N.B. : Il faut évaluer la TA (une femme enceinte dont la tension est $\geq 14/9$ doit être considérée comme hypertendue).

✓ Inspection idem 2^{ème} trimestre

Il faut apprécier la forme de l'utérus (longitudinale ou transversale)

❖ Les différentes étapes

✓ Examen obstétrical

- Mensurations

Comparer ces mensurations aux mensurations précédentes.

N.B. : Une hauteur utérine plus importante peut évoquer :

un gros fœtus

un hydramnios

une grossesse gémellaire

✓ Examen obstétrical

- - La palpation

Elle doit être indolore

Elle recherche le type de présentation :

elle est céphalique (quand la tête est en contact avec le détroit supérieur)

✓ Examen obstétrical

- - La palpation

elle est un siège (quand la tête est dans le fond utérin)

elle est transversale (quand les deux pôles sont dans les flancs).

elle recherche le côté du dos, palpé comme un plan dur

(**manœuvre de Budin**)

✓ Examen obstétrical

- - Auscultation

Les bruits du cœur fœtal doivent être réguliers et non synchrones au pouls de la mère. Ils doivent être compris entre 120 et 160 battements par minute)

- - Examen gynécologique

L'examen au spéculum (diagnostic de grossesse)

Le Toucher Vaginal recherche :

Le col : sa position, sa longueur, sa consistance, son degré d'ouverture. Il confirme la présentation perçue à la palpation.

- - Examen gynécologique

Le Toucher Vaginal recherche :

Au cours du TV il faut :

Apprécier le segment inférieur mince (bien formé), flottant (mal formé) . **Situé entre le corps et le col de l'utérus.**

- - Examen gynécologique

Le Toucher Vaginal recherche :

Déterminer le bishop (dilatation, longueur, consistance, position, présentation)

Examiner le bassin (ogive pubienne, promontoire, lignes innominées)

Examiner le périnée (souple, lésions inflammatoires, rigide, cicatrices)

Apprécier toujours ce que ramène le doigtier

➤ CAT

- Curative

Elle est fonction des plaintes de la gestante.

- Préventive

Prescrire :

Anti anémique

Anti palustre si nécessaire

Vacciner si nécessaire

CPN DU 3^{ème} TRIMESTRE

➤ CAT

- Examens complémentaires

Relancer le bilan prénatal en fonction de l'âge gestationnel,
Demander l'échographie.

➤ CCC

Elle doit être en rapport avec l'état de la gestante.

➤ Rendez-vous et quand revenir

LA DERNIERE CPN



ROLE DE L'INFIRMIER DANS L'ALIMENTATION DE LA FEMME ENCEINTE ALLAITANTE

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTÉ - INFAS

Blvd de Marseille, 18 BP 720 Abidjan 18, Tel.: (225) 21005660 / 21001906 – Email: info@infas.ci – site web: www.infas.ci

OBJECTIF GENERAL

Connaitre les conseils à donner à une femme enceinte ou allaitante relatifs à une bonne alimentation.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Expliquer l'importance de l'alimentation au cours de la grossesse ou l'allaitement
2. Citer les facteurs favorisant une mauvaise alimentation
3. Décrire les conséquences d'une alimentation inadéquate chez la mère et l'enfant
4. Expliquer les composantes d'une alimentation équilibrée

IMPORTANCE DE L'ALIMENTATION DE LA FEMME ENCEINTE ET ALLAITANTE

Besoins nutritionnels pendant la grossesse et l'allaitement ➡ augmentés.

Bonne alimentation pendant la grossesse ➡ moyens pour prévenir les accouchements prématurés et les problèmes dans le développement du nourrisson.

Future mère bien nourrie, s'il n'y a pas d'autres problèmes de santé ➡ un enfant de poids et de taille normale et avec une résistance suffisante aux infections ou autres maladies.

IMPORTANCE DE L'ALIMENTATION DE LA FEMME ENCEINTE ET ALLAITANTE

Apports alimentaires accrus

Ils sont indispensables pour soutenir la croissance du fœtus et l'allaitement futur. En effet les réserves de graisses maternelles sont nécessaires pour aider le fœtus à se développer et pour allaiter le bébé par la suite.

IMPORTANCE DE L'ALIMENTATION DE LA FEMME ENCEINTE ET ALLAITANTE

Pendant la grossesse

Les femmes enceintes doivent augmenter les apports alimentaires de 200 calories au moins par jour (Exemple une bouillie de maïs et 12 arachides répondent à ce besoin supplémentaire).

IMPORTANCE DE L'ALIMENTATION DE LA FEMME ENCEINTE ET ALLAITANTE

Pendant l'allaitement

Les femmes qui allaitent ont besoin d'environ 650 calories supplémentaires soit pratiquement l'équivalent d'un repas supplémentaire par jour pour répondre aux besoins énergétiques de l'allaitement.

IMPORTANCE DE L'ALIMENTATION DE LA FEMME ENCEINTE ET ALLAITANTE

Apports adéquats en micronutriments

Il faut diversifier le régime alimentaire pour améliorer la qualité et l'apport en micronutriments (Fer/Acide Folique, Iode, vitamine A etc.) :

Augmenter la consommation quotidienne de fruits et légumes

Consommer les produits animaux

Utiliser les aliments fortifiés tels que l'huile enrichie en vitamine A

IMPORTANCE DE L'ALIMENTATION DE LA FEMME ENCEINTE ET ALLAITANTE

Apports adéquats en micronutriments

Les besoins en iode augmentent au cours de la grossesse. Il faut consommer du sel iodé car la carence en iode affecte le développement cérébral du fœtus, la croissance et compromet la réussite scolaire et l'intelligence de l'enfant.

IMPORTANCE DE L'ALIMENTATION DE LA FEMME ENCEINTE ET ALLAITANTE

Apports adéquats en micronutriments

Si les besoins en micronutriments ne sont pas satisfaits à partir de sources alimentaires, il faudra prendre des suppléments contenant de l'acide folique, du fer, de la vitamine A, du Zinc, du calcium et d'autres nutriments pour constituer des réserves et améliorer l'état nutritionnel des femmes.

FACTEURS FAVORISANT LA MAUVAISE ALIMENTATION

- Préjugés socioculturels : refus de consommation de certains aliments
- Interdits alimentaires : tabou, totem
- Problèmes de sécurité alimentaire
- Maladies.

CONSEQUENCES D'UNE ALIMENTATION INADEQUATE

Pour la mère

- Asthénie ;
- Anémie avec une augmentation du risque d'hémorragie
- Diminution de la résistance aux infections
- Avortement spontané
- Malnutrition
- Augmentation du risque de décès pendant ou après l'accouchement.

CONSEQUENCES D'UNE ALIMENTATION

INADEQUATE

Pour l'enfant

- Prématurnité
- Petit poids de naissance
- Malformations (crétinisme, surdi-mutité, anomalie du tube médullaire)
- Mort-né.

COMPOSANTES D'UNE ALIMENTATION EQUILIBREE

La ration alimentaire de la femme enceinte ou allaitante doit être équilibrée c'est-à-dire qu'elle doit lui apporter tous les nutriments essentiels :

En quantité suffisante

En proportion convenable.

Cet équilibre est généralement obtenu en associant judicieusement les aliments disponibles provenant de chaque groupe d'aliments représenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau II : Différents groupes d'aliments (carré des

Aliments énergétiques de base Racines et tubercules : Manioc, ignames, taro, pommes de terre, patates douces... Céréales : riz, maïs, blé, mil, sorgho... Fruit féculent : banane plantain...	Aliments énergétiques de complément Huiles, margarine, beurre, arachide, soja, avocat... Sucre.
Aliments énergétiques de base Racines et tubercules : Manioc, ignames, taro, pommes de terre, patates douces... Céréales : riz, maïs, blé, mil, sorgho... Fruit féculent : banane plantain...	Aliments énergétiques de complément Huiles, margarine, beurre, arachide, soja, avocat... Sucre.

Tableau II : Différents groupes d'aliments (carré des

1. Aliments de construction Produits d'origine animale : Poisson, viande, œufs, poulet, laits, yaourts, fromages, chenilles, insectes, crevettes, grenouilles, serpents... Légumineuses et graines oléagineuses: Haricots, pois, lentilles, arachides, graines de courge, soja, sésame...	Aliments de protection Légumes : tomates, gombos, feuilles manioc, amarante, épinard, oseille... Fruits : mangues, bananes douces, papayes, citrons, ananas, orange, mandarine, avocat...
1. Aliments de construction Produits d'origine animale : Poisson, viande, œufs, poulet, laits, yaourts, fromages, chenilles, insectes, crevettes, grenouilles, serpents... Légumineuses et graines oléagineuses: Haricots, pois, lentilles, arachides, graines de courge, soja, sésame...	Aliments de protection Légumes : tomates, gombos, feuilles manioc, amarante, épinard, oseille... Fruits : mangues, bananes douces, papayes, citrons, ananas, orange, mandarine, avocat...

CONSEILS A DONNER A LA FEMME ENCEINTE OU ALLAITANTE

- Avoir une alimentation équilibrée, riche en énergie ;
- Consommer du sel iodé (tous les membres de sa famille)
- Réduire les activités quotidiennes ;
- Eviter la consommation des excitants : café, tabac, alcool, drogue...



ROLE DE L'INFIRMIER DEVANT UNE ANEMIE ET GROSSESSE

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTE - INFAS

Blvd de Marseille, 18 BP 720 Abidjan 18, Tel.: (225) 21005660 / 21001906 – Email: info@infas.ci – site web: www.infas.ci

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à permettre à l'étudiante sage-femme de licence II de connaître les mesures préventives de l'anémie chez la femme enceinte.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Définir l'anémie chez la femme enceinte
- Citer les causes les plus fréquentes de l'anémie chez la femme enceinte
- Décrire les stratégies de prévention de l'anémie chez la femme enceinte

L'anémie au cours de la grossesse est définie comme étant la diminution du taux d'hémoglobine en dessous de 11g/100ml de sang. Elle se traduit cliniquement par une fatigue intense et des essoufflements, une pâleur des muqueuses (conjonctives, langue) et des téguments (paume des mains et des pieds).

CAUSES ESSENTIELLES

- ✓ Malnutrition (Alimentation pauvre en fer)
- ✓ Paludisme
- ✓ Parasitoses intestinales
- ✓ Hémorragies
- ✓ Hémoglobinopathies (drépanocytose)

MESURES PREVENTIVES DE L'ANEMIE AU COURS DE LA GROSSESSE

Mesures hygiéno-diététiques

Promouvoir la consommation d'aliments riches en fer et en acide folique (feuilles vertes : patate, manioc, épinard, haricot vert)
Déconseiller la consommation de boissons alcoolisées, de kaolin



MESURES PREVENTIVES DE L'ANEMIE AU COURS DE LA GROSSESSE



Traitement préventif

Du paludisme (cf paludisme et grossesse)

Des parasitoses intestinales à partir de la 16^{ème} semaine

MESURES PREVENTIVES DE L'ANEMIE AU COURS DE LA GROSSESSE

Supplémentation en fer et en acide folique

Période de début du traitement : CPN 1 (entre la 6^{eme} et la 12^{eme} semaine)

Posologie pendant la grossesse : FER élément 60 mg + acide folique 5 mg (1 CP de chaque par jour jusqu'à l'accouchement).
Forme combinée (1 CP de FER + acide folique par jour jusqu'à l'accouchement).

MESURES PREVENTIVES DE L'ANEMIE AU COURS DE LA GROSSESSE

Supplémentation en fer et en acide folique

Posologie en post-partum : 200mg de FER élément + 4 mg d'acide folique en 2 prises par jour pendant deux semaines après l'accouchement.

NB : chez la femme enceinte sous prophylaxie antianémique contenant de l'acide folique, il est conseillé de donner la dose de S/P en TPI et lui demander d'observer une semaine d'arrêt avant de reprendre la prophylaxie antianémique avec l'acide folique.



ROLE DE L'INFIRMIER DEVANT UN PALUDISME ET GROSSESSE

OBJECTIF GENERAL

Connaitre les éléments de prise en charge du paludisme chez la femme enceinte

OBJECTIFS SPECIFIQUES

1. Décrire les moyens de prévention du paludisme chez la femme enceinte
2. Enoncer les éléments de la prise en charge du paludisme simple et du paludisme grave
3. Expliquer les conseils à donner aux femmes enceintes sur le paludisme

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Décrire les moyens de prévention du paludisme chez la femme enceinte
- Enoncer les éléments de la prise en charge du paludisme simple et du paludisme grave
- Expliquer les conseils à donner aux femmes enceintes sur le paludisme

PREVENTION DU PALUDISME

La prévention du paludisme chez la femme enceinte s'articule autour de l'association des trois éléments suivants :

Le traitement préventif intermittent (TPI)

L'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII)

L'assainissement du cadre de vie.

TRAITEMENT PRÉVENTIF INTERMITTENT POSOLOGIE ET PROGRAMMATION

Une seule dose comprend trois comprimés de sulfadoxine 500 mg + pyriméthamine 25 mg (S/P)

La posologie est de 02 doses espacées d'au moins un mois. La première dose est administrée à partir de la 16^{ème} semaine après l'apparition des mouvements actifs du fœtus.

La dernière dose doit être donnée avant le dernier mois du terme de la grossesse

INSTRUCTIONS POUR DONNER LE TRAITEMENT PRÉVENTIF INTERMITTENT

S'assurer que la femme est enceinte d'au moins 16 semaines et que les mouvements actifs du fœtus sont apparus

Demander si la femme a utilisé de la S/P au cours des 4 dernières semaines

Demander si elle est allergique à la S/P ou à d'autres sulfamides (surtout si elle a eu des éruptions cutanées graves)

INSTRUCTIONS POUR DONNER LE TRAITEMENT PRÉVENTIF INTERMITTENT

- Expliquer ce qui va être effectué ; répondre aux questions de la femme
- Fournir un verre et de l'eau potable
- Observer directement la femme prendre la dose requise à chaque prise
- Noter dans le registre de consultation, le carnet de consultation mère enfant, sur la fiche de consultations prénatales et/ou la fiche clinique, que la dose de S/P a été prise
- Expliquer à la femme quand elle devrait revenir .

CONTRE-INDICATIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE LA S/P

Ne pas donner la S/P à la femme enceinte avant l'apparition des mouvements actifs du fœtus (16 semaines)

Ne pas donner aux femmes ayant rapporté être allergiques à la S/P ou autres sulfamides

Ne pas donner la deuxième dose de S/P sans respecter le délai d'un mois au moins avec la première dose.

NB :VIH/SIDA et paludisme pendant la grossesse :

Le VIH/SIDA réduit la résistance de la femme au paludisme
Chez les femmes atteintes du VIH/SIDA, ne prenant pas le cotrimoxazole, le traitement préventif intermittent (TPI) doit être donné à partir de la 16^{ème} semaine à raison de 3 doses espacées d'au moins 01 mois chacune.

La dernière dose doit être donnée avant le dernier mois du terme de la grossesse.

Chez La femme enceinte infectée par le VIH et sous traitement au cotrimoxazole pour la prévention des affections opportunistes, ➡ pas donner de dose de S/P en TPI.

Avant 16 semaines de grossesse, ➡ encourager la femme à dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticide et à mettre des grillages anti- moustiques ou rideaux aux portes et fenêtres de l'habitation.



UTILISATION DES MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES D'INSECTICIDE

Insister sur l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticide par la femme enceinte dès la CPN 1.

ASSAINISSEMENT DU CADRE DE VIE

Destruction des gîtes larvaires

Pose de grillages anti moustiques aux portes et fenêtres des habitations

Nettoyage régulier des alentours des concessions

Aménagement d'endroits pour le recueil et la destruction des ordures ménagères

PRISE EN CHARGE DU PALUDISME SIMPLE ET GRAVE

Fournir des antipaludiques de premier choix (cf directives nationales en annexes et cours de gynéco-obstétrique)
Traiter la fièvre (paracétamol, éponger la patiente à l'eau tiède)
Diagnostiquer et traiter l'anémie
Prévenir la déshydratation et l'hypoglycémie (eau, boisson sucrée).



ADMISSION DE LA PARTURIENTE EN SALLE D'ACCOUCHEMENT

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION DES AGENTS DE SANTÉ - INFAS

Blvd de Marseille, 18 BP 720 Abidjan 18, Tel.: (225) 21005660 / 21001906 – Email: info@infas.ci – site web: www.infas.ci

OBJECTIF GENERAL

Appréhender les étapes de l'admission de la parturiente en salle de travail.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- Décrire tous les éléments de l'accueil en salle de travail ;
- Décrire toutes les étapes qui composent l'examen d'entrée en salle de travail.

INTRODUCTION

L'admission est la réception de la parturiente (femme en travail) à laquelle s'attache une psychologie toute spéciale. Elle a pour but de mettre en confiance et informer la parturiente. Ceci étant, l'infirmier doit faire l'examen d'entrée, établir le dossier médical ou le compléter, faire le bilan ou le compléter si nécessaire et adopter une conduite à tenir adéquate.

ACCUEIL

L'accueil consiste à :

- saluer affectueusement la parturiente
- se présenter à elle
- l'identifier
- l'installer confortablement en décubitus latéral gauche
- l'informer des gestes à faire

ACCUEIL

exploiter le carnet de santé ou le dossier si elle en possède
la préparer psychologiquement

Tout cela doit se faire dans une atmosphère détendue, dans un
climat de confiance afin de faciliter l'examen d'entrée.

EXAMEN D'ENTREE

Il doit être précis et rapide et ne doit ignorer aucun aspect.

2-1- Le but

Il permet de regrouper un ensemble de données par l'interrogatoire, les examens cliniques, les examens complémentaires en fonction desquels on prendra la décision. L'attitude que l'infirmier doit adopter est différente selon qu'il soit devant une urgence ou non.

L'interrogatoire ou anamnèse

L'infirmier doit noter l'heure et la date d'entrée de la parturiente. Demander son carnet de santé mère-enfant, vérifier l'identité et tous les renseignements en rapport avec la parturiente : Nom, prénom(s), âge, gestité, parité, conditions socio-économiques, antécédents médicaux, gynécologiques et obstétricaux, renseignements sur la grossesse actuelle, son âge, son terme et son suivi.

L'interrogatoire ou anamnèse

Elle doit s'informer sur le motif d'entrée en salle de travail :

- contractions utérines ;
- perte des eaux, si pertes des eaux noter la date, l'heure, l'abondance, la coloration et l'odeur ;
- des saignements ;
- fièvre ;
- l'existence ou non des mouvements actifs du fœtus.

Examen clinique

Examen général

Peser :calculer la prise de poids total pendant la grossesse (12kg au plus) ;

La mesurer de la taille (si la taille < 1,50 m Bassin rétréci probable) ;

Apprécier son état général ;

Vérifier sa démarche pour déceler une boiterie, une déformation de sa colonne vertébrale (apprécier le losange de Mikaelis) ;

Examen clinique

-Examen général

Recueillir les urines à la recherche de l'albumine et du sucre ;
Installer la parturiente sur une table propre ;
Prendre la tension artérielle, le pouls et la température ;
Vérifier si la femme a été groupée sinon prélever le sang pour le groupe sanguin rhésus ;
Noter ces résultats dans le dossier ou le registre d'accouchement.

INSPECTION

Elle doit se faire dans l'ordre chronologique et recherche au niveau:

- du visage : des œdèmes ;
- des conjonctives : une pâleur ou un ictère ;
- de la bouche : une carie dentaire, une langue saburrale, un herpès labiale etc.....
- du cou : des ganglions, une hyperthyroïdie (goitre) ;
- des seins : un nodule, une malformation ou une éventuelle sécrétion en pressant le mamelon ;

INSPECTION

- de l'abdomen : la forme de l'utérus et son grand axe, une cicatrice abdominale et la cause, la présence de vergetures ;
- de la vulve : une excision, des varices, des œdèmes, un écoulement ; des condylomes (crête de coq) ;
- des membres inférieurs : les varices au niveau de la face interne de la cuisse, les œdèmes au niveau des malléoles, du dos du pied et de la face externe.
- Noter toutes les observations dans le dossier.

EXAMEN OBSTETRICAL

Installer (position gynécologique).

Mesurer la hauteur utérine (normale 32cm ,33cm, 34cm)

Si la hauteur utérine supérieure à la normale il faut rechercher :

- un gros fœtus
- une grossesse multiple
- un hydramnios.

EXAMEN OBSTETRICAL

Si la hauteur utérine est inférieure à la normale, il faut rechercher :

- une erreur de terme,
- une menace d'accouchement prématuré
- une hypotrophie fœtale.

EXAMEN OBSTETRICAL

Mesurer le périmètre abdominal passant par l'ombilic.

Faire le palper à la recherche :

de la présentation (céphalique, siège, transversale)

du niveau de la présentation (haute et mobile, amorcée, fixée, engagée)

de la position du dos par la manœuvre de Budin

EXAMEN OBSTETRICAL

Auscultier et chronométrer les bruits du cœur fœtal, qui doivent être réguliers être ≥ 120 et ≤ 160 battements par minute.

Faire le toucher vaginal pour :

- apprécier le col (sa position, sa longueur, sa consistance, et sa perméabilité)

- le segment inférieur (formé ou mal formé)

- confirmer la présentation,

- apprécier la poche des eaux ; elle peut être intacte (plate ou bombante), ou rompue.

EXAMEN OBSTETRICAL

Si elle est rompue, demander impérativement la date et l'heure de la rupture. Si la durée de la rupture est supérieure ou égale à 06 heures, faire systématiquement une antibiothérapie.

Vérifier l'aspect du liquide amniotique, sa couleur, son abondance, son odeur.

examiner le bassin :

essayer d'atteindre le promontoire

suivre les lignes innominées

EXAMEN OBSTETRICAL

Au niveau de l'excavation :

apprécier la concavité sacrée qui normalement est profonde et régulière

rechercher les épines sciatiques latéralement : normalement elles sont non saillantes.

Au niveau du détroit inférieur

apprécier l'ogive pubienne

apprécier la souplesse du périnée

EXAMEN OBSTETRICAL

Au terme de cet examen minutieux et en absence de souffrance foetale, l'infirmier doit surveiller le travail à l'aide d'un partographe.

Dans ce cas :

administrer un lavement évacuateur si elle est en début de travail
raser la vulve (jamais le mont de venus)

faire la toilette vulvaire avec un antiseptique et de l'eau tiède
porter à la parturiente une garniture propre ou stérile.

EN CAS D'URGENCE

L'infimier doit :

noter l'heure et la date d'entrée de la parturiente
déterminer l'urgence (hémorragie, procidence du cordon, éclampsie)

Le pronostic maternel et/ou fœtal étant en jeu la sage-femme doit contrôler dès l'entrée en salle de travail les constantes de la mère et apprécier immédiatement l'état du fœtus (BD CF et MAF).

EN CAS D'URGENCE

Si le fœtus est encore vivant l'extraire de l'utérus est une urgence, alors la césarienne s'impose.

L'infirmier doit préparer la parturiente (préparation psychologique, raser, grouper, faire le bilan d'hémostase TP, TCK, NFS).

CONCLUSION

Durant cette période, la femme vit de grands bouleversements au niveau inconscient pouvant se traduire par des attitudes agressives parfois infantiles. L'infirmier doit donc sécuriser la future mère, la soutenir à tout point de vue. Une mauvaise attitude peut entraîner chez la parturiente une méfiance, une crispation, une absence de coopération lors de l'examen d'entrée voire de l'accouchement.

Merci de votre attention!

